视网膜静脉阻塞｜三源整合

中国共识解读2024｜SEMI/SERV意见2025 · 正面

① 首诊＋全身同步评估

分CRVO/BRVO；HRVO另注。看视力、眼前后节、OCT及灌注；同步筛查和控制血压、血糖、血脂等，勿因等病因结果延误眼部治疗。

中①2024 p187；西2025 PDF2–4、6

② 缺血：别混影像阈值

中①参考：7视野FFA NP>10 DA；超广角>75 DA、缺血指数≥35%。中②不支持仅凭10 DA。结合临床及检查方法，不作统一公式。

中①2024 p187；中②2024 p266

③ 新生血管/NVG优先

关注虹膜、房角与眼底新生血管。中①病程>2个月强调房角镜。发生新生血管/NVG：按情境抗VEGF＋相应激光/PRP＋降眼压。

中①2024 p187–188；中②2024 p265–266

④ ME：观察还是注药

明显视功能损伤及时干预；视功能尚好可个体观察。没有统一视力/CMT切点，0.5不是通用注药阈值。中①：每月1次×3次后按需。

中①2024 p187–188；中②2024 p265–266

临床要点摘要；完整条件与原文缺项见提取表。
100%原尺寸 · 双面长边翻转

视网膜静脉阻塞｜三源整合

中国共识解读2024｜SEMI/SERV意见2025 · 背面

⑤ 激素与激光边界

抗VEGF反应差且无激素禁忌可考虑激素二线，关注眼压和白内障。无新生血管不常规预防PRP；CRVO不推荐黄斑格栅激光。

中①2024 p188；中②2024 p265–266；西2025 PDF6

⑥ 西意见特定抗凝方案

仅特定新发CRVO、病程<30天：西意见提出LMWH抗凝剂量10天后改预防剂量，总3个月。证据有限，mg/IU剂量未明确，需内科评估。

中①2024 p187–188；中②2024 p265–266；西2025 PDF6–8

⑦ 病因、ASA与特殊人群

西：<50岁和/或双眼者可扩查。ASA须另有独立适应证，勿只因RVO新启。妊娠等需个体选药，未给统一孕哺/儿科剂量方案。

中①2024 p187–188；中②2024 p265–266；西2025 PDF5–8

⑧ 随访与治疗失败复评

中①随访至少2年；西：缺血CRVO每月、非缺血每2–6个月；活动性ME仍按治疗计划复评。缺血加重/反应差重新查病因和危险因素。

中①2024 p187–188；西2025 PDF6

临床要点摘要；完整条件与原文缺项见提取表。

100%原尺寸 · 双面长边翻转